

# Analiza 1

## **Motiv prezentare:**

Pacienta se prezintă pentru palpitații ocazionale, episoade de dispnee la efort moderat și valori tensionale crescute în ultimele 2 săptămâni.

## **Antecedente personale patologice:**

- Hipertensiune arterială esențială grad II
- Dislipidemie
- Fără antecedente de infarct miocardic sau AVC
- Neagă diabet zaharat

## **Antecedente heredocolaterale:**

- Tată cu antecedente de cardiopatie ischemică
- Mamă hipertensivă

## **Examen clinic:**

- Stare generală bună
- TA: 150/95 mmHg
- Puls: 88 bpm, regulat
- SatO2: 98%
- Auscultație cardiacă: zgomote cardiace ritmice, fără sufluri patologice evidente
- Fără edeme periferice

## **Electrocardiogramă (EKG):**

- Ritm sinusal
- Frecvență cardiacă: 86 bpm
- Ax electric normal
- Fără modificări acute de ischemie

## **Ecocardiografie:**

- FEVS: 60%
- Funcție sistolică păstrată
- Hipertrofie ventriculară stângă ușoară
- Valve cardiace cu aspect și funcție în limite normale
- Fără revărsat pericardic

## **Analize recomandate:**

- Hemoleucogramă completă

- Profil lipidic
- Glicemie
- Creatinină, uree
- TSH
- Electroliți serici

**Diagnostic:**

1. Hipertensiune arterială esențială grad II
2. Palpitații în curs de investigare
3. Dislipidemie

**Recomandări:**

- Monitorizare tensională la domiciliu 7 zile
- Regim hiposodat și hipolipidic
- Reducerea consumului de cafeină
- Activitate fizică moderată minimum 30 minute/zi
- Control cardiologic în 1 lună

**Tratament recomandat:**

- Perindopril 5 mg 1 cp/zi
- Bisoprolol 2.5 mg 1 cp/zi
- Rosuvastatin 10 mg seara